

MALADIE GOUTTEUSE : ACTUALITES 2016

Docteur Muriel JUMEL DUCLOS, rhumatologue.

1 PROBLEMATIQUE :

La goutte est une maladie fréquente, souvent prise en charge lors d'une hospitalisation, d'une part parce que la crise aiguë microcristalline est douloureuse, d'autre part parce qu'elle survient souvent dans un contexte de stress physique, lors d'une infection ou d'un événement cardiovasculaire. En général du ressort de la médecine générale, elle peut nécessiter un avis spécialisé. Pour permettre une meilleure prise en charge de nos patients, je vous propose donc un résumé des données et recommandations actuelles.

2 MESSAGES CLEFS : LE DIAGNOSTIC :

- La **ponction articulaire** est toujours souhaitable quand elle est réalisable techniquement : d'une part elle soulage le patient, d'autre part elle permet de confirmer le diagnostic ou plus exactement d'exclure le diagnostic différentiel qui est l'arthrite septique.
- Le seul cas où la question se pose est celui d'une crise de goutte chez un patient goutteux déjà sous antibiotiques pour une infection grave : dans ce cas, la ponction n'apporte pas grand-chose puisque la présence de cristaux n'exclut pas une arthrite septique décapitée.
- Il est possible de voir en cas de goutte une fièvre même élevée et un franc syndrome inflammatoire biologique, jusqu'à 300 de CRP, une hyperleucocytose, une cholestase. En revanche, classiquement il n'y a pas de frisson. Cela n'exclut en rien **la nécessité d'éliminer une atteinte septique.**
- La seule certitude diagnostique certaine d'une crise de goutte est la découverte de cristaux à la ponction articulaire avec un liquide inflammatoire stérile en culture (et non décapité), en sachant qu'il peut y avoir une coexistence de cristaux d'acide urique et de pyrophosphate de calcium.
- Une uricémie normale pendant une crise aiguë n'exclut pas le diagnostic : l'IL1 et l'IL6 déchargées pendant la crise font temporairement et artificiellement baisser l'uricémie. A contrôler dans ce cas à 4 à 6 semaines.
- Bien évidemment, on peut avoir une arthrite septique et une hyperuricémie, donc une uricémie élevée n'affirme pas le diagnostic !

- La goutte peut être poly articulaire d'emblée, mais ne débute pour ainsi dire jamais aux membres supérieurs : une mono-arthrite de poignet, même inflammatoire, même avec une hyperuricémie élevée, ne doit pas être considérée comme une crise de goutte si le patient n'a jamais eu d'atteinte antérieure des membres inférieurs ...
- La crise de goutte arrive souvent en post traumatique, mais il faut penser à éliminer une fracture d'un métatarse associée...

En cas de suspicion de goutte et d'impossibilité de ponction :

- Le **score de NIJMEGEN** peut être utilisé : un score <4 sur 13 élimine le diagnostic, un score >8 équivaut à 80% de diagnostic positif (VPP 0.87 si score >8) :

Facteur	score
Sexe masculin	2
Accès similaire antérieur	2
Survenue < 24h	0.5
rougeur	1
Localisation 1 MTP	2.5
HTA ou autre FDR CV	1.5
Uricémie > 60	3.5

Le « test » à la colchicine reste valable mais il est à noter que les doses préconisées à l'heure actuelle, bien moindres, permettent rarement un soulagement aussi rapide et spectaculaire qu'auparavant.

3 MESSAGES CLEFS : LA PRISE EN CHARGE DE LA CRISE AIGUË MICROCRISTALLINE :

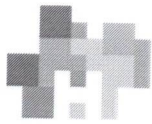
- La colchicine et les AINS per os restent le traitement de référence, si les co morbidités le permettent.
- En cas d'intolérance à la colchicine, les AINS sont tout aussi efficaces s'ils peuvent être utilisés.
- Les corticoïdes oraux doivent être réservés aux seuls cas où tout autre traitement est impossible : toxicité, mais aussi moins bonne efficacité dans la goutte (pas dans la chondrocalcinose en revanche ou ils sont très efficaces) et surtout effets rebonds.
- La ponction soulage, l'infiltration cortisonnée aussi, et permet une toxicité moindre.



- Toujours : repos articulaire, glaçage
- La **posologie** de la colchicine tend à diminuer : on recommande désormais à J1 : un comprimé à 1mg en dose de charge suivi une heure plus tard d' ½ comprimé ; et de J2 jusqu'à guérison complète (souvent 4-5 jours à ces posologies) ½ comprimé trois fois par jour. Cela permet une nette amélioration de la tolérance digestive, au prix d'une guérison parfois plus lente.
- Attention à la prescription de colchicine : il y a **d'innombrables interactions médicamenteuses** dont les **statines** (à suspendre le temps du traitement) ; les AVK (la colchicine déséquilibre l'INR) ; certains antibiotiques dont les macrolides (association contre indiquée) et la pristinamycine ; le ketoconazole ; les antipaludéens de synthèse ; le vérapamil....
- Si le patient reçoit déjà un traitement hypouricémiant (allopurinol, febuxostat ...) celui-ci **ne doit pas** être interrompu.
- Point particulier sur l'insuffisance rénale : les **néphrologues** admettent de la colchicine à petites doses pour des périodes de 3 à 5 jours même avec des insuffisances rénales de stade III. On peut initier par exemple un traitement par ½ comprimé de colchimax tous les 2 jours... A savoir puisque les AINS sont proscrits.
- Rappel sur les toxicités de la colchicine : vous connaissez tous la toxicité digestive et rénale ; se souvenir de la **toxicité médullaire**, des **myopathies avec rhabdomyolyse**, et des **neuropathies**...
-

4 MESSAGES CLEFS : PREVENIR LA CRISE SUIVANTE

- Désormais, lorsque le diagnostic est certain et le patient à risque de récidiver, le traitement hypouricémiant peut être instauré dès la première crise : l'**attitude traditionnelle** d'attendre la seconde voire la troisième crise n'est plus recommandée.
- Par conséquent : il faut toujours faire le point sur les autres éléments du **syndrome métabolique** et les prendre en charge, car ils font partie des facteurs de risque : obésité, diabète, dyslipidémie, HTA, insuffisance coronarienne, SAS, psoriasis...
- On note l'âge (< 40 ans pour un premier épisode ?) ; l'insuffisance rénale ; l'uricémie (contrôlée quatre semaines après l'accès le cas échéant, en sachant que le risque d'une nouvelle crise est majeur si l'uricémie est > 80).
- On recherche les **causes médicamenteuses** : cytolytiques, ciclosporine et tacrolimus, thiazidiques et furosémide, pyrazinamide et ethambutol, **aspirine** surtout à faible dose...
- Pour la prise en charge tensionnelle privilégier le LOSARTAN et les inhibiteurs calciques qui sont uricosuriques.



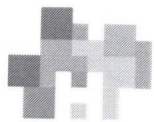
- Sur le plan **alimentaire** on recherche les traditionnels apports en abats, charcuterie, crustacés, alcools forts ; mais aussi les bières y compris sans alcool et le fructose, avec les apports de fruits et certains sodas. En revanche les purines végétales ne sont pas assimilées par les mêmes voies métaboliques et le patient peut conserver asperges et rhubarbe à son menu sans arrière pensée !

5 BILAN PRETHERAPEUTIQUE

- Le patient est jeune (surtout <40), atteint d'un syndrome métabolique, a une uricémie > 80 ; ou il s'agit d'une énième crise, ou il présente des tophus, donc il va être nécessaire d'introduire un traitement hypouricémiant. Avant une consultation rhumatologique, un bilan est souhaitable :
- Radiographies des pieds et des genoux, échographie des pieds et des genoux : on recherche une arthropathie goutteuse a minima, des tophus infra clinique dont le suivi guidera la thérapeutique, à l'échographie un signe du **double contour**.
- Bilan biologique standard : NFS BHC complet (toxicité hépatique de l'allopurinol !) fonction rénale (médico légale !) mais aussi uraturie des 24h et bilan des facteurs de risque cardiovasculaire ; bien évidemment uricémie...
- Echographie rénale à discuter là encore pour trouver des lithiases, surtout si la goutte récidive, si le patient a de nombreux facteurs de risque, s'il a déjà fait des coliques néphrétiques, s'il a une hématurie ou une protéinurie à la BU. Pour **mémoire**, les lithiases uriques sont radiotransparentes.

6 INTRODUCTION DU TRAITEMENT MEDICAMENTEUX HYPOURICEMIAN

- A débiter, si on choisit de traiter, trois semaines après la crise selon les recommandations traditionnelles. Là encore, l'attitude tend à ralentir ce délai et à traiter plutôt plus rapidement qu'auparavant.
- A débiter par un **inhibiteur de la xanthine oxydase** en l'absence de goutte liée aux cytolytiques.
- En première intention, toujours privilégier l'allopurinol pour tout patient si le débit de filtration glomérulaire est supérieur à 30-40ml/mn.
- En revanche la posologie maximale acceptable est fonction du DFG, d'où la nécessité de le connaître et de le suivre. Pour une insuffisance rénale de stade I-II, la posologie maximale d'allopurinol est de 200 à 300 mg/jour... mais cela suffit à un grand nombre de patients...



- En cas de prescription d'allopurinol, bien surveiller l'INR (si AVK) et prévenir le patient de consulter en cas de fièvre ou d'éruption cutanée entre la sixième et la huitième semaine (DRESS syndrome). Pour mémoire, il n'y a **plus de risque de DRESS Syndrome** au-delà du troisième mois.
- **Commencer à la posologie de 100mg/jour** et jamais plus (médico légal) et doser l'uricémie à quinze jours ; on augmente alors par paliers de 50mg à 100mg tous les quinze jours jusqu'à l'obtention de l'uricémie cible. Pour mémoire, une posologie de 400mg/jour est tout à fait possible.
- **L'uricémie cible** est < 60, parfois 50 si les facteurs de risques sont nombreux et en particulier en cas de tophus. Il n'y a aucun intérêt à obtenir une uricémie plus basse.
- Normalement, on prescrit de façon parallèle une **prophylaxie par colchimax** à **petites doses**, les recommandations actuelles proposant **1/2 comprimé par jour** à espacer (1/2 comprimé un jour sur deux ou un jour sur trois) en cas d'insuffisance rénale modérée ou d'intolérance. Cette prophylaxie est **à poursuivre six mois après l'obtention de la cible thérapeutique** (uricémie < 60 ou 50), et plus longtemps en cas de tophus (jusqu'à disparition des tophus en pratique, d'où l'intérêt du bilan radiographique et échographique)
- **En cas d'insuffisance rénale** avec une clairance < 30- 40ml/mn, on n'a pas d'AMM mais les néphrologues préfèrent alors utiliser le fébuxostat (1/2 comprimé de febuxostat 80mg ou un comprimé un jour sur deux) ; et dans ce même cas préfèrent s'abstenir de colchicine au long cours.
- Le febuxostat est probablement prescrit par excès à l'heure actuelle. Pour une clairance normale ou du moins supérieure à 60-50ml/mn la question ne doit pas se poser et l'allopurinol doit être préféré de façon systématique en première intention, le fébuxostat pouvant être proposé en cas d'inefficacité de l'allopurinol à la posologie maximale possible pour la fonction rénale du patient ou en cas d'intolérance.
- La co prescription d'uricosuriques est du ressort du spécialiste.

J'espère vous avoir apporté sur ce sujet toujours d'actualité.

Cordialement,

Dr Muriel Jumel Duclos